

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Paulo Roberto de Carvalho Scamilla

EXAME nº: 2701-2 CPAP

SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez

DATA: 28/10/2013

IDADE: 60 anos

Comentários:

Exame **iniciado** às 23h19min e **concluído** às 06h57min. A **latência para o sono** foi de 6 minutos e a **latência para o estágio REM**, de 62 minutos. O **tempo total de sono** foi de 377,5 minutos, com **eficiência de sono** (T T S / T T R)* de 82%. A distribuição do sono mostrou 20,3% de **estágio 1**, 37,2% de **estágio 2**, 19,1% de **estágio 3** e 23,4% de **estágio REM**. No período total de sono permaneceu 81 minutos em **vigília**, ocorreram 206 **microdespertares** (índice: 32,7/hora).

O **índice de movimentos periódicos de membros** foi de 19,9/hora.

O **índice de apneia/hipopneia** foi de 4,1/hora, sendo 0,2 apneia/hora e 4 hipopneia/hora. O **índice de distúrbio respiratório** (apneia+hipopneia+RERA) foi de 5,9/hora. A **saturação basal da oxi-hemoglobina** foi de 94%, sendo a saturação média de 93% e a mínima de 82%.

(*) **T T S** ⇨ Tempo Total de Sono **T T R** ⇨ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

O paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho auto CPAP Vantage (Resmed®), modo manual, sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia de Matos (CREFITO: 29544F). Ele usou a máscara nasal Mirage Activa shallow® (Resmed®). A pressão final recomendada do CPAP foi de 11,6 cm de H2O.

Apesar do índice de apneia/hipopneia normal (4,1/hora; normal até 4/hora), o índice de distúrbio respiratório estava levemente aumentado (5,9/hora). Registraram-se episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina, despertares e arritmia cardíaca. As frequências cardíacas foram: mínima: 56; máxima: 166 bpm.

Ronco ausente com a pressão adequada.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu logo (latência para o sono: 6 min.; normal até 30 min) – ele ingeriu 12 mg de Lexotan® às 21h20min. A latência para o estágio REM estava encurtada (62 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 82%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (206; 32,7/hora; normal até 15/hora) – observou-se a intrusão de ritmo rápido medicamentoso nos estágios 2 e 3. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (20,3%; normal: 8-10%), 3 (19,1%; normal: 10-12%) e REM (23,4%; normal: 19-20%), e a redução do estágio 2 (37,2%; normal: 45-55%).

Aumento leve do índice de movimentos periódicos de membros (19,9/hora; índice leve: 5 a 24/hora). Observaram-se movimentos de pernas após despertares.